

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	主動脈內氣球幫浦導管裝置術之護理 Intra-Aortic Balloon Pumping (IABP) insertion Nursing Care				
編號	A31000-Q03-W-B12	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 11 月 08 日
版本/總頁數	第 3.4 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解主動脈內氣球幫浦導管裝置術的定義、治療對象、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位。

三、說明

(一) 定義

增加心肌所需氧氣、減少左心室後負荷、增加心輸出量、增加對生命器官之血液輸送，由主治醫師向病人及家屬做詳細的解釋。可在加護病房病人單位、心電圖監視器、急救設備齊全下，由醫師執行、護理師協助下操作，嚴守無菌技術。

(二) 治療對象

- 1.對治療無反應的心因性休克或充血性心衰竭。
- 2.無法脫離體外心肺機循環。
- 3.不穩定型心絞痛。
- 4.急性二尖瓣逆流及心室中隔缺損。
- 5.低心輸出量症後群。
- 6.冠狀動脈血管成型術失敗。
- 7.心臟移植前的準備。
- 8.心肌梗塞對血栓溶解劑治療無效。
- 9.三條冠狀動脈疾病或左冠狀動脈合併左心室功能缺損。

主題名稱	主動脈內氣球幫浦導管置術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B12	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	2/6

(三) 護理問題

1. 低心輸出量。
2. 呼吸道清除功能不良。
3. 疼痛不適。
4. 易感染。

(四) 護理措施及衛教指導

1. 接上心電圖及血壓監測機。
2. 插管前應檢查下肢的所有脈搏，直至導管移除前。
3. 每班至少監測 CVP 一次。
4. IABP 導管剛置入時，每 30 分鐘監測心跳、血壓、呼吸及心電圖變化連續 2 小時，情況穩定改以每小時監測。
5. 每班評估並記錄患者意識狀況、四肢血流灌注，尤其是置入導管的患肢動脈。
6. 維持適當的氧合：每班評估呼吸音，適時清除呼吸道分泌物，並依病況提供適當的氧氣療法，適時監測動脈血液氣體分析值，維持在 PH：7.35-7.45、PaO₂ > 90mmHg、PaCO₂：35-45mmHg。
7. 協助病人採取舒適的姿勢，置入側下肢盡量勿彎曲。
8. 抬高床頭 < 30 度，以防氣球往主動脈之上部移動，可藉 X 光片評估導管位置(第 3、4 肋間)，應保持頂端在左鎖骨下動脈下 1-2cm，底端應在腎動脈上。
9. 每班評估導管置入處傷口，每日更換敷料，注意有無滲血及追蹤凝血功能檢查，如：PT、APTT。
10. 每班紀錄 IABP 的輔助比例：充氣放氣時間，並能於波型上確認出不正常充氣、放氣時間，並注意氣球破裂的徵象：管路可見血液、舒張期的增加部份 (Augmentation) 消失。如有調整使用之輔助比例，須記錄在監測表單。
11. 置放在病人體內的氣球導管，勿使其靜止時間超過 30 分鐘，以免產生血栓。
12. 導管為雙腔式，須接上壓力監測系統，維持管道通暢與評估壓力。
13. 置入側肢體避免髖關節彎曲，但可作踝關節的被動關節運動及協助翻身側臥，下

主題名稱	主動脈內氣球幫浦導管置術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B12	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	3/6

肢伸直以減輕不適及末梢血栓的形成。

14.拔管後應持續觀察生命徵象及血液動力學等變化以利評估。

15.因充氣導管持續充放氣破壞了血液組成，須監測血小板數、血紅素及血比容積。

16.協助病人攝取營養與維持排泄功能。

17.病人因病況危急，可能出現明顯的焦慮害怕，甚至拔管不合作，除予以適當約束外，更須加強治療性溝通及正向的心理支持。

18.停機步驟應注意：

(1)減少充放氣次數及充氣量，由 1：1 改 1：2 然後 1：3，在每次改變後至少觀察 30 分鐘的心輸出量、肺動脈楔壓、血壓、心跳次數、小便量，一切穩定後再進行下一步。當調 1：3 時勿超過 2 小時，因可能引起血栓。

(2)拔管前檢查病人的血小板 PLT、血紅素 HCT、凝血時間 ACT 數值，必要時依醫囑備血備用。

(3)協助醫師拔管，醫師雙手壓迫止血 15-30 分，更換敷料用 2 公斤砂袋加壓 6-8 小時，密切觀察生命徵象，每 15 分鐘測量一次共 4 次，而後改 30 分鐘測量一次維持 2 小時，然後每小時測量一次共兩次，情況穩定無出血改為常規測量。

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	主動脈內氣球幫浦導管置術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B12	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	4/6

六、參考資料

- (一) 張美玉、劉慧玲(2020)．實用重症護理學，五南。
- (二) 蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌、李瓊淑(2020)．心臟疾病之護理．新編內外科護理學下冊（第八版，739-886 頁），華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	主動脈內氣球幫浦導管置術後之護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B12	版本	第 3.4 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改說明內容，護士改護理師。	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部。 2.修正標點符號。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 第三項說明內容部份修辭。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.02.14	3.3	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 02 月 14 日照 護標準組會議通過； 108 年 3 月 13 日護理 長會議通過；108 年 3 月 18 日督導會議通 過公布。
109.08.06	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

